

# Assistenza infermieristica e cura di una persona autistica a ogni età

**La guida cumulativa per infermieri e personale di RSA e infermieristica di comunità — lungo ogni tappa in cui l'infermieristica e la cura residenziale incontrano una persona autistica, dalla salute studentesca alla cura residenziale ad alto supporto. Una scheda di riferimento estesa; abbinatela alle guide rapide per singola tappa. (Questa colonna copre la cura infermieristica e residenziale; non si applica alle righe prescolare, primaria o secondaria.)**

## L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di una persona si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Gli ambienti infermieristici e di cura — luminosi, rumorosi, imprevedibili, pieni di contatto e richieste — sono tra i **più difficili** in cui entra una persona monotropica, e scatenano spesso shutdown, meltdown ed evitamento delle cure. Qualsiasi sia la tappa, le priorità infermieristiche si sovrappongono: riducete il carico sensoriale, comunicate alla lettera e per iscritto, indagate prima il dolore e le cause fisiche, proteggete routine e agency, e non presumete mai l'incapacità dalla comunicazione atipica. Una cura infermieristica prevedibile e informata sull'autismo cambia gli esiti — e aiuta ogni paziente, non solo quelli autistici.

## Cosa aiuta a ogni età

- **Riducete il carico sensoriale** — stanza più quiete, luce più soffusa, meno bip, niente profumi forti; offrite la fascia più quiete.
- **Comunicate alla lettera e per iscritto**; spiegate ogni passaggio prima di farlo; permettete lunghi silenzi per l'elaborazione; offrite follow-up scritto.
- **Indagate prima il dolore e le cause fisiche** per ogni nuovo malessere — stitichezza, dolore dentale, infezioni, attrezzature mal calibrate sono colpevoli comuni e nascosti.
- **Protegete routine, oggetti e interessi** — sono ancora di identità e sicurezza; conservateli attraverso ricoveri e cambi.
- **Usate il decision-making supportato**; permettete un accompagnatore di fiducia e un kit sensoriale; non presumete mai l'incapacità dalla comunicazione atipica.
- **Avere un piano calmo per meltdown/shutdown**: riducete gli stimoli, assicurate la sicurezza, date tempo e spazio — non contenete; documentate gli adattamenti efficaci.
- **Mantenete l'équipe infermieristica coordinata** — un profilo individualizzato condiviso e adattamenti documentati rendono la cura efficace automatica attraverso i cambi di personale e i ricoveri, invece di una lotta ricorrente.
- **Pianificate ogni transizione e ricovero in anticipo** — un „passaporto sanitario”, oggetti familiari e un contatto noto trasformano i momenti più difficili (ospedale, trasloco, cambio di personale) in momenti gestibili.

## Cosa evitare a ogni età

- Forzare il contatto visivo, procedure a sorpresa, contenzione o frasi del „sii coraggioso!”.

- Lasciare che pochi minuti calmi e mascherati sovrastino l'autovalutazione e l'anamnesi.
- Equiparare il „non lamentarsi” al „non soffrire”; presumere l'incapacità da una risposta lenta o atipica.
- Frammentare la cura tra personale che cambia senza un profilo condiviso — fili che si incrociano e spiegazioni ripetute sono essi stessi fonte di malessere.

### Note rapide per tappa

---

#### Infermieristica in residenza universitaria / salute studentesca

Trascuratezza di sé, ritiro e crisi segnalano spesso burnout. Offrite opzioni scritte/online e un accompagnatore; chiedete proattivamente di salute mentale, sonno, alimentazione e sicurezza; trattate la crisi come bisogno non soddisfatto; segnalate benessere, mentor e supporto di crisi.

#### Infermieristica della medicina del lavoro / aziendale

Riconoscete il **burnout autistico** (distinto dalla depressione); mediate i reasonable adjustments; iniziate i farmaci a basso dosaggio e titolate lentamente. Valutate suicidalità e ADHD, ansia, disturbi del sonno e gastrointestinali co-occorrenti.

#### Infermieristica materna / di comunità (genitori autistici)

Rendete la cura perinatale prevedibile e calma; offrite opzioni a prima lo scritto; chiedete proattivamente di dolore, esaurimento e alimentazione. Cercate il burnout e la malattia mentale perinatale; non fraintendete il sovraccarico come „non si lega”.

#### Personale di RSA / casa di riposo (adulti più anziani)

Costruite le cure attorno alla prevedibilità; proteggete routine e oggetti lifelong; indagate prima il dolore; comunicate alla lettera e lentamente. Distinguate con cura la differenza autistica dalla demenza; affrontate l'isolamento sociale; siate onesti sulle scarse evidenze.

#### Infermieristica residenziale ad alto supporto (qualsiasi età)

Prima il dolore e le cause fisiche; prevedibilità e routine/oggetti conservati; ridotto carico sensoriale; decision-making supportato; un piano calmo e scritto per meltdown/shutdown (nessuna contenzione); un passaporto sanitario per i ricoveri.

**Il burnout autistico non è depressione** — esaurimento cronico, perdita di competenze e ridotta tolleranza agli stimoli; trattarlo come depressione o „sforzati di più” lo approfondisce e alza il rischio di suicidio. **Il masking in ambulatorio è costoso** — non lasciate che pochi minuti composti sovrastino l'anamnesi. **Dolore e interocezione** — „non si lamenta” ≠ „non soffre”; chiedete proattivamente e aspettatevi pattern sintomatici ritardati/atipici. **Il nuovo malessere in una persona ad alto supporto è una red flag medica** finché dolore e sovraccarico non sono esclusi. **Gli adattamenti aiutano tutti** — una cura adatta ai sensi, prevedibile e chiaramente comunicata giova anche a pazienti con ADHD, PTSD, ansia, cali sensoriali e cambiamenti cognitivi. Mettete sempre al centro l'individuo.

#### Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parti 3–5), la guida per la **famiglia** (Parte 5, RSA e ospedali) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima („persona autistica”). **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico.** Il monotropismo è una teoria potente ma ancora in via di sviluppo; le evidenze sull'età avanzata e sull'alto supporto sono scarse — siate onesti sull'incertezza e adattatela alla singola persona.

**Fonti chiave.** Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Kelly Mahler (2024, interocezione); Klein et al. (2024, invecchiamento); AASPIRE Healthcare Toolkit / AHAT (autismandhealth.org); Autism Society (2025, meltdown/shutdown); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space); NTG (autismo e demenza). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.